

TEMA 3.5 • UROLOGÍA

Cáncer de Próstata: Screening, Clínica y Diagnóstico

PERFIL EUNACOM 1.12.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **cáncer de próstata** es una de las neoplasias más prevalentes en el hombre adulto. Su manejo clínico es particular debido a su historia natural, que suele ser de crecimiento lento, y a la controversia existente respecto al beneficio real del tamizaje poblacional masivo.

Screening (Tamizaje)

El screening del cáncer de próstata es un tema de debate constante. Existe escasa evidencia de que reduzca significativamente la mortalidad global por tres razones fundamentales:

- **Edad de presentación:** Es un cáncer del adulto mayor. Muchos pacientes fallecen por otras causas antes de que el cáncer de próstata limite su esperanza de vida.
- **Historia natural:** Generalmente es de crecimiento lento y tratable incluso cuando se detecta por síntomas.
- **Falsos positivos:** El screening genera una alta tasa de falsos positivos, lo que deriva en biopsias innecesarias con riesgos de complicaciones (infección, sangrado).

Sin embargo, la mayoría de las guías (incluyendo la chilena) recomiendan realizarlo bajo un modelo de **decisión compartida**.

Población objetivo y temporalidad

- **Inicio general:** A los **50 años**. - **Inicio precoz (40-45 años):** En pacientes con antecedentes familiares directos o factores de riesgo genéticos como mutaciones en **BRCA1/2** o **Síndrome de Lynch**. - **Cese del screening:** A los **70 años** o cuando la **expectativa de vida es menor a 10 años**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Un tacto rectal sospechoso (nódulo palpable) es indicación de biopsia **aunque el APE sea normal**.

Clínica y Sintomatología

En etapas iniciales, el cáncer de próstata suele ser **asintomático** (por eso se busca mediante screening). Cuando presenta síntomas, estos pueden ser:

- **Uropatía obstructiva baja:** Disminución del chorro urinario, intermitencia, pujo, tenesmo (similar a la **Hiperplasia Prostática Benigna**).
- **Hematuria:** Menos frecuente, pero posible.
- **Síntomas de enfermedad avanzada:**
 - **Dolores óseos:** Especialmente en columna lumbar (sitio frecuente de metástasis).
 - **Baja de peso y compromiso del estado general.**
 - **Linfedema:** Por compromiso de ganglios ilíacos y pelvianos.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Las metástasis óseas del cáncer de próstata son clásicamente **osteoblásticas** (se ven "blancas" o densas en la radiografía), a diferencia de la mayoría de los cánceres que producen lesiones **osteolíticas**.

Diagnóstico y Pronóstico

El diagnóstico se confirma con la **biopsia**. Una vez diagnosticado, se debe establecer el pronóstico del paciente utilizando diversas variables:

- **Nivel de APE:** Valores > 20 ng/ml sugieren mayor riesgo de metástasis; > 100 ng/ml es altamente sugerente de enfermedad diseminada.
- **Score de Gleason:** Es la escala histológica de agresividad.
 - Va de 2 a 10.
 - **Gleason ≤ 6:** Bien diferenciado (mejor pronóstico).
 - **Gleason ≥ 8:** Indiferenciado (peor pronóstico).
- **Tacto Rectal (T):** Tamaño y extensión local del tumor.
- **Estudio de extensión (Imágenes):**
 - **Cintigrafía ósea:** Para buscar metástasis óseas (alta sensibilidad).
 - **Resonancia Magnética (RM) Multiparamétrica:** Útil para etapificación local.
- *** PET-PSMA:** Es el examen de elección actual para detectar recurrencias o metástasis precoces, aunque su disponibilidad es limitada.

Resumen de Factores Pronósticos

TABLA 3.5.2: FACTOR VS BUEN PRONÓSTICO

FACTOR	BUEN PRONÓSTICO	MAL PRONÓSTICO
APE	Bajo (< 10)	Alto (> 20)
Gleason	≤ 6	8 - 10
Tacto Rectal	No palpable o pequeño	Nódulo grande o invasión extraprostática

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda que el cáncer de próstata metastatiza principalmente por vía **hematógica al hueso** y por vía **linfática a los ganglios pelvianos**.

En el siguiente artículo revisaremos el **Cáncer de Próstata: Manejo y Tratamiento**, donde analizaremos desde la vigilancia activa hasta la

NOTA CLÍNICA

El Antígeno Prostático Específico (APE) es una proteína producida por las células de la próstata. Es **específico de órgano**, pero **no específico de cáncer**. Puede elevarse en **Hiperplasia Prostática Benigna**, **Prostatitis**, tras un tacto rectal vigoroso o después de actividad sexual.

Criterios de Biopsia: Guía Internacional vs. Guía MINSAL

El diagnóstico definitivo se realiza mediante una **biopsia transrectal ecoguiada**. Las indicaciones para solicitarla varían ligeramente entre las recomendaciones internacionales y la normativa chilena (AUGE/GES).

Recomendación Internacional (Basada en APE)

TABLA 3.5.1: VALOR APE (NG/ML) VS CONDUCTA

VALOR APE (NG/ML)	CONDUCTA
< 4	Normal. Control en 1-2 años.
4 - 10	"Zona gris". Repetir en 6-8 semanas para descartar elevaciones transitorias. Si persiste > 4, biopsiar.
> 10	Derivación inmediata a Urología para biopsia.

Criterios Guía MINSAL (Chile)

Para el EUNACOM, es vital conocer los criterios que obligan a la derivación en el sistema público chileno: 1. **APE ≥ 4 ng/ml:** En una sola toma (no exige repetición obligatoria como la internacional). 2. **Tacto Rectal Alterado:** Presencia de nódulos, pétreo o irregular, independiente del valor del APE. 3. **Velocidad de APE:** Aumento ≥ 0,75 ng/ml al año (comparando con el valor del año anterior). 4. **APE ajustado por edad:** Menores de 50 años: > 2,5 ng/ml. Menores de 60 años: > 3,5 ng/ml.

prostatectomía y la deprivación androgénica.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de cincuenta y cinco años, asintomático, en control de salud habitual. Tiene antecedente de padre con cáncer de próstata diagnosticado a los sesenta años. Se solicita APE como screening y resulta en seis punto tres. ¿Cuál es la conducta más adecuada según la guía internacional?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cáncer de Próstata: Screening, Clínica y Diagnóstico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El screening de cáncer de próstata con APE se realiza entre los cincuenta y setenta años; se inicia a los cuarenta en pacientes con antecedentes familiares o mutaciones BRCA1, BRCA2 o síndrome de Lynch
- APE menor a cuatro es negativo; entre cuatro y diez se repite en seis a ocho semanas; mayor a diez va directamente a biopsia prostática transrectal guiada por ecografía
- La guía Minsal chilena agrega: APE mayor o igual a cuatro sin repetición, tacto rectal con nódulo, velocidad de APE mayor o igual a cero coma setenta y cinco al año, y APE ajustado por edad
- Las metástasis del cáncer de próstata son osteoblásticas y se ven blancas en la radiografía, igual que el cáncer de mama, a diferencia de la mayoría de los cánceres que producen lesiones osteolíticas
- El pronóstico del cáncer de próstata depende del APE, del score de Gleason histológico, del tacto rectal y de las imágenes; APE mayor a veinte indica mayor riesgo de metástasis a distancia
- El score de Gleason va de dos a diez; mayor a seis indica peor pronóstico histológico por mayor indiferenciación tumoral
- El tacto rectal no está recomendado como screening rutinario, pero si se realiza y muestra un nódulo prostático es indicación de biopsia transrectal

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CÁNCER DE PRÓSTATA: SCREENING, CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO)

PREGUNTA 1

Paciente de cincuenta y cinco años, asintomático, en control de salud habitual. Tiene antecedente de padre con cáncer de próstata diagnosticado a los sesenta años. Se solicita APE como screening y resulta en seis punto tres. ¿Cuál es la conducta más adecuada según la guía internacional?

- A)** Derivar inmediatamente a urología para biopsia prostática transrectal
- B)** Repetir el APE en seis a ocho semanas para confirmar si es elevación real
- C)** Considerar el screening negativo porque el antecedente familiar no modifica el punto de corte
- D)** Iniciar tamsulosina y repetir el APE en seis meses
- E)** Realizar biopsia transrectal solo si el tacto rectal muestra un nódulo

PREGUNTA 2

Paciente de setenta y dos años con dolores lumbares crónicos de seis meses de evolución, baja de peso de seis kilogramos en tres meses y dificultad para iniciar la micción. El APE resulta en ciento cuarenta y dos. Se realiza radiografía de columna lumbar que muestra múltiples lesiones óseas. ¿Cuál es la característica esperada de las metástasis óseas de este cáncer?

- A)** Lesiones osteolíticas que se ven oscuras en la radiografía, como la mayoría de los cánceres
- B)** Lesiones osteoblásticas que se ven blancas en la radiografía, similares al cáncer de mama
- C)** Lesiones mixtas osteolíticas y osteoblásticas, típicas del cáncer de próstata avanzado
- D)** Lesiones osteolíticas que se ven blancas porque el hueso está calcificado por el tumor
- E)** No hay metástasis óseas en el cáncer de próstata ya que metastiza principalmente por vía linfática

PREGUNTA 3

Paciente de cuarenta y cinco años consulta por síntomas de uropatía obstructiva baja moderada. No tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata. El APE resulta en cinco punto uno. Al realizarle tacto rectal se palpa la próstata aumentada de tamaño, lisa, sin nódulos. Según la guía Minsal chilena, ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** No se requiere biopsia porque el tacto rectal no mostró nódulo y el APE es menor a diez
- B)** Indicar biopsia prostática transrectal porque el APE es mayor o igual a cuatro según la guía Minsal
- C)** Repetir el APE en seis a ocho semanas antes de decidir sobre biopsia
- D)** Iniciar tratamiento de hiperplasia prostática benigna y controlar APE en un año
- E)** Indicar biopsia solo si el APE supera diez en el control a las seis semanas

RESUMEN: CÁNCER DE PRÓSTATA: SCREENING, CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en hombres y una causa importante de mortalidad oncológica masculina. El screening con antígeno prostático específico es controvertido porque no tiene evidencia sólida de reducir la mortalidad, ya que es un cáncer del adulto mayor que frecuentemente no llega a causar la muerte antes que otras comorbilidades, tiene lenta progresión, y el APE genera una cantidad importante de falsos positivos que llevan a biopsias innecesarias. Sin embargo, la mayoría de las guías internacionales y chilenas recomiendan realizarlo entre los cincuenta y setenta años, iniciando a los cuarenta años en pacientes con antecedentes familiares de cáncer de próstata o factores de riesgo genético como mutaciones BRCA1, BRCA2 o síndrome de Lynch. Los puntos de corte del APE determinan la conducta. APE menor a cuatro: screening negativo, control en uno a dos años. APE entre cuatro y diez: se repite en seis a ocho semanas para confirmar elevación real antes de biopsiar. APE mayor a diez: se deriva a urología para biopsia prostática transrectal guiada por ecografía. La guía Minsal chilena añade indicaciones adicionales: APE mayor o igual a cuatro sin repetición previa, tacto rectal con nódulo, velocidad de APE mayor o igual a cero coma setenta y cinco al año, y APE ajustado por edad. El tacto rectal no está recomendado como screening rutinario, pero si se realizó y muestra un nódulo, es indicación de biopsia. La clínica del cáncer de próstata habitualmente es una uropatía obstructiva baja cuando se detecta por síntomas, o bien hematuria. En etapas avanzadas aparecen dolores óseos especialmente lumbares por metástasis óseas hematógenas, y baja de peso. Las metástasis óseas del cáncer de próstata son osteoblásticas y se ven blancas en la radiografía, igual que en el cáncer de mama. El pronóstico depende del nivel de APE, del score de Gleason histológico, del tacto rectal, y de las imágenes. El APE mayor a veinte indica mayor riesgo de metástasis a distancia.